Namn: Adele Rönkkö & Evelina Solem

Program: Sjuksköterskeprogrammet, 180hp, Institutionen för vårdvetenskap

Kurs: Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGK13, VT26

Nivå: Grundnivå

Handledare: Annica Lagerin

Examinator: Jeanette Eckerblad

Att förlora ett barn:

Kvinnors upplevelser av missfall – En litteraturöversikt

To lose a child

Women's Experiences of Miscarriage – A Literature Review

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Varje minut sker det 44 graviditetsförluster i världen. I Sverige slutar ca 15–25% av alla graviditeter i ett missfall. Det är i många fall svårt att fastställa orsaken till att missfallet sker. Att drabbas av ett missfall innebär att kvinnan genomgår en graviditetsförlust före graviditetsvecka 22. Missfall är en av det vanligaste men allvarligare graviditetskomplikationerna och förknippas inte med allvarlig fysisk sjukdom men är sammankopplat till en betydande psykisk och social påverkan.

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av missfall.

Metod: Metoden är en litteraturöversikt som baseras på tio vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ studiedesign. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl och kvalitetsgranskades utifrån Friberg. Artiklarna analyserades utifrån Fribergs fyra analyssteg.

Resultat: Resultatet presenteras med tre huvudteman: (1) Emotionellt lidande, (2) Brister i vården och (3) Att leva vidare med förlusten. Kvinnorna upplevde ett emotionellt lidande med känslor som skuld, rädsla, ensamhet och en förlust av framtiden. De upplevde även flera brister i vården och bemötande av vårdpersonalen. Bristande informationen under vårdtiden samt ett bemötande med bristande empati, okänslighet och dömande attityder. Tiden efter missfallet fortsatte även att påverka kvinnorna negativt.

Slutsats: De emotionella och psykiska besvären hos kvinnorna visar på att missfall är en komplex situation. Resultaten visar på att kvinnors negativa upplevelser av vården har en stor inverkan på deras välbefinnande. Ett lyhört, informativt och respektfullt bemötande kan leda till en ökad trygghet. En förbättring av vården behövs med en ökad medvetenhet, utbildning samt riktlinjer.

Nyckelord: Bemötande, Empati, Kvinnor, Lidande, Missfall, Upplevelser.

ABSTRACT

Background: Every minute there are 44 pregnancy losses in the world. In Sweden almost 15–25% of the pregnancy ends with miscarriage. In many cases there are difficulties to determine why the miscarriage happens. Having a miscarriage means that the women undergo a pregnancy loss before 22 weeks of the gestational. Miscarriage is a usual pregnancy complication that is not correlated with critical physical illness but is more related to a significant psychological and social impact.

Aim: The aim of this study was to highlight women's experience of miscarriage.

Method: The method is a literature review based on ten scientific original articles with qualitative study design. The articles were searched in the databases PubMed and Cinahl and were quality assessed according to Friberg. The articles were analysed using Friberg's four-step analytical framework.

Results: The results are presented under three main themes: (1) Emotional suffering, (2) Deficiencies in care and (3) Living with the loss. Women experienced emotional suffering including feelings of guilt, fear, loneliness and a sense of a lost future. They also reported several deficiencies in the care, as well as experiences of empathy deficits, insensitivity and judgemental attitudes. The period following the miscarriage continued to have a negative impact on the women.

Conclusion: The emotional and psychological distress expressed by the women indicates that miscarriage is a complex situation. The results show that women's negative experiences of healthcare have a significant impact on their well-being. A responsive, informative and respectful approach can contribute to increased feelings of reassurance. Improvements in care are needed through greater awareness, education and clear guidelines.

Keywords: Abortion Spontaneous, Empathy, Experience, Miscarriage, Suffering, Treatment, Women.

INLEDNING **5**

BAKGRUND **1**

DEN GENERELLA GRAVIDITETEN 1

MISSFALL 1

SJUKSKÖTERSKANS ARBETE 3

PROBLEMFORMULERING **5**

SYFTE **5**

TEORETISK REFERENSRAM **5**

METOD **7**

DATAINSAMLING 7

DATAANALYS 9

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN **10**

RESULTAT **11**

EMOTIONELLT LIDANDE 11

BRISTER I VÅRDEN 13

ATT LEVA VIDARE MED FÖRLUSTEN 14

DISKUSSION **16**

METODDISKUSSION 16

RESULTATDISKUSSION 18

KLINISKA IMPLIKATIONER **21**

FÖRSLAG FORTSATT FORSKNING **22**

SLUTSATS **23**

REFERENSFÖRTECKNING **24**

BILAGA 1. SÖKMATRIS **29**

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT **30**

BILAGA 3, KVALITETSGRANSKNING **37**

INLEDNING

Att drabbas av missfall kan innebära både fysiska och psykiska påfrestningar. För många kvinnor innebär det inte enbart en fysisk påverkan utan även en emotionell upplevelse. Bellhouse m.fl. (2018) belyser att missfall är något som sällan pratas om öppet i samhället. Kvinnorna upplever en tydlig tystnad och stigma kopplat till missfall. I hälso- och sjukvården riktas ofta fokus mot de fysiska aspekterna av missfallet. Detta innebär att de psykiska och emotionella konsekvenserna däremot riskerar att nedprioriteras. Det finns därför ett behov av att fördjupa kunskapen om kvinnors upplevelser av ett missfall. Genom att synliggöra deras berättelse kan en ökad förståelse skapas för de emotionella och psykologiska aspekterna av händelsen. En sådan förståelse är central för att kunna utveckla ett mer personcentrerat och empatiskt bemötande inom vården både i det akuta skedet och under den efterföljande tiden.

Författarna har själva erfarenheter av kvinnosjukvård från både arbete och VFU placeringar. Utifrån detta kändes det självklart att skriva specifikt om kvinnosjukvård. Författarna har erfarenheter av utmaningar att bemöta det emotionella tillståndet som kan uppstå vid ett missfall. Att kunna bemöta patienten och visa stöd kan vara extra svårt i förhållande till tidsbrist och andra patienter med andra sjukdomstillstånd. Därför vill författarna belysa kvinnornas unika upplevelser av missfall.

BAKGRUND

Den generella graviditeten

En normal graviditet varar cirka 40 veckor och räknas från och med sista menstruationens första dag. Under graviditeten sker omfattande fysiologiska och hormonella förändringar hos kvinnan samtidigt som embryot och fostret utvecklas successivt (Borgfeldt m.fl., 2019). Graviditeten delas traditionellt in i tre trimestrar. Trimester 1 börjar från sista mensens första dag och fram till vecka 14. Vid vecka 12 är fostret ca 5 cm och väger ca 30g. Trimester 2 omfattar veckorna 15–28. Fostret vid vecka 24 är ca 30cm och väger ca 600g. Den sista trimestern omfattar resterande veckor från 29–42 (Svensk MeSH, u.å.; Borgfeldt m.fl., 2019).

Fosterutvecklingen delas in i tre stadier, det odifferentierade, de embryonala och det fetala stadiet. Det odifferentierade stadiet omfattar de första två veckorna efter befruktningen och innefattar celldelning, hormonproduktion (hCG) samt implantation i livmoderslemhinnan. Det embryonala stadiet sträcker sig från graviditetsvecka 5 till 10 och kännetecknas av organanläggning där bland annat nervsystem, hjärta och kärlsystem börjar utvecklas. Det sista stadiet kallad för fetala stadiet pågår från vecka 11 till förlossningen och präglas främst av tillväxt och mognad av de organ som tidigare har anlagts (Borgfeldt m.fl., 2019).

Missfall

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO och ICD-11 (2025) definieras ett missfall eller även kallad spontan abort en graviditetsförlust som sker innan vecka 22. Om information om kvinnans graviditetslängd ej är tillgänglig tillämpas istället kriteriet att fostret väger mindre än 500 gram. Definitionen av ett missfall varierar dock globalt mellan olika länder. I Sverige definieras ett missfall före graviditetsvecka 22 (Borgfeldt m.fl., 2019), i England definieras det före vecka 24 (Demakakos m.fl., 2020) medan Australiens definition är före graviditetsvecka 20 (Miscarriage Australia, 2025).

Det finns flera olika termer som förklarar det medicinska tillståndet kvinnan går igenom. Bottomley & Bourne (2009) belyser vikten av att använda rätt term och anpassa i mötet med patienter. Termer som missfall, tidig fosterdöd eller tidig graviditetsförlust bör i första hand användas. Ordet spontan abort bör undvikas för att inte riskera förväxling med inducerad graviditetsavbrytande även kallad abort på grund av den sociala stigman som finns runt termen.

Borgfeldt m.fl. (2019) beskriver att en av de vanligaste komplikationerna under tidig graviditet är missfall. Under den tidiga graviditeten är vaginala blödningar ett vanligt symtom. Detta kan dock ha flera ofarliga orsaker till exempel hormonella förändringar eller ökad skörhet i kroppens slemhinnor. Samtidigt kan blödning utgöra ett tidigt tecken på ett pågående missfall. Vaginala blödningar och smärta är symtom på ett pågående missfall. Det är i många fall svårt att fastställa den exakta orsaken till att kvinnan drabbats. Kromosomavvikelser står för ett betydande andel av tidiga graviditetsförluster men även hormonella rubbningar eller strukturella förändringar i livmodern kan vara bidragande faktorer (Borgfeldt m.fl., 2019).

Det finns olika typer av riskfaktorer som kan öka risken för att drabbas av ett missfall. Al-Almani m.fl. (2024) tar upp aktiv rökning under graviditeten som en av de största riskfaktorerna. Enligt Bottomley & Bourne (2009) ses även hög ålder som en stor riskfaktor. Ca 20% av alla graviditeter hos 35 åringar slutar i ett missfall jämfört med kvinnor i 42 års åldern där ca 55% drabbas (Bottomley & Bourne, 2009). Andra riskfaktorer är etnicitet, fertilitetssvårigheter eller tidigare benägenhet för missfall inom familjen (Al-Almani m.fl., 2024; Quenby m.fl., 2021). Missfall är vanligt förekommande ungefär 15–25% av alla graviditeter slutar i ett missfall i Sverige (Lind, 2023). Enligt Quenby m.fl. (2021) uppskattas antalet missfall i världen till 23 miljoner varje år. Enligt statistiken är risken för missfall 15,3% av alla identifierade graviditeter. Detta innebär att det sker 44 graviditetsförluster varje minut.

Behandling av ett missfall

Svensk förening för obstetrik & gynekologi (SFOG, 2021) beskriver att behandling efter ett konstaterat missfall kan ske på olika sätt. Vid en tom kavitet sker ingen medicinsk eller kirurgisk åtgärd. Ingen uppföljning planeras in utan kvinnan söker vård vid behov. Uppvisar kvinnan däremot symtom som blödningar och smärta i samband med att det finns synlig kvarvarande graviditetsvävnad på ultraljud kallas det för ett inkomplett missfall.
Vid ett inkomplett missfall finns det en expektans på två veckor där mer än 80% av kvinnorna aborterar spontant. Patienter uppmanas själva ta ett graviditetstest efter ca 2–4 veckor och söka vård vid fortsatta symtom. Ingen uppföljning planeras in men vid ett oförändrat läge sätts antingen medicinsk eller kirurgisk behandling in. Medicinsk behandling innebär att kvinnan får läkemedel som hjälper kroppen att stöta bort hela fostret tillsammans med smärtstillande läkemedel. Den medicinska behandlingen kan ske i hemmet upp till graviditetsvecka 10+0. Ingen uppföljning planeras in men skriftlig och muntlig information ska ges. Kvinnan uppmanas att

söka sig tillbaka vid fortsatta besvär. I första hand väljs den medicinska behandlingen men vid särskilda anledningar eller om den medicinska behandlingen misslyckas så väljs den kirurgiska behandlingen. Den kirurgiska behandlingen genomför genom en vacuumaspiration som sker på operation under generell anestesi (SFOG, 2021).

Tiden efter missfallet

Missfall är en vanlig men allvarlig graviditetskomplikation men är inte förknippat med allvarlig fysisk sjukdom eller dödlighet. Dock är missfall förknippat med en betydande social och psykologisk påverkan på kvinnan (Bottomley & Bourne, 2009). Borgfeldt m.fl. (2019) belyser vikten av att erbjuda kvinnan ett psykosocialt stöd eller en kuratorskontakt.

De fysiska komplikationerna är liknande oavsett om patienten genomgår en behandling för sitt missfall eller inte (Lind, 2023). Enligt Redinger & Nguyen (2024) är risken för fysiska komplikationer efter avslutad behandling lika hög oavsett behandlingsalternativ. De främsta komplikationerna är kvarvarande graviditetsvävnad, endometrit, anemi som kräver blodtransfusion samt sepsis. Graviditetsförluster under den andra trimestern har en generell högre risk för att drabbas av ytterligare komplikationer som till exempel blödningar, lungemboli, cervixruptur samt infektioner (Redinger & Nguyen, 2024).

Under den första veckan har kvinnan en högre infektionsrisk och därmed bör hon undvika att använda tampong eller ha samlag. Kvinnan bör även vara observant på feber, tilltagande buksmärta eller andra tecken på misstänkta komplikationer. Vid misstänkta komplikationer ska kvinnan snarast höra av sig till sin mottagning eller söka vård. Blödningar och avslag ska även ha försvunnit inom 7–10 dagar. Om dem inte har avtagit bör kvinnan även så vända sig till vården. Om missfallet har skett efter graviditetsveckorna 14–16 kan kvinnans mjölkproduktion komma igång efter några dagar. Kvinnorna ska därför erbjudas läkemedel som hämmar mjölkproduktionen i kroppen. Den första menstruationen förväntas komma igång inom 2–6 veckor efter missfallet. Efter den första menstruationen ska den fortsätta komma regelbundet och det finns inga hinder för att försöka för en ny graviditet (Borgfeldt m.fl., 2019).

Sjuksköterskans arbete

Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för omvårdnad som bygger på vetenskap, etik och en humanistisk människosyn. Yrkesrollen innebär självständiga kliniska bedömningar, stöd för att främja och bevara hälsa samt respekt för patientens integritet och självbestämmande.

Sjuksköterskan ska ansvara för att säkerställa trygg, personcentrerad och evidensbaserad vård i samverkan med andra professioner (Svensk sjuksköterskeförening, 2024). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2021) tar upp vikten av att bemöta människor med respekt, empati, omsorg, lyhördhet, tillit, integritet, medkänsla och rättvishet.

Tidigare studier visar att sjuksköterskor upplever att vårdmötet med patienter som genomgår eller drabbats av ett missfall är komplext, utmanade samt känslomässigt laddade (Martins m.fl., 2023). Martins m.fl. (2023) tar upp flera egenskaper som är viktiga för sjuksköterskor som träffar patienter med ett pågående eller genomgått missfall. En egenskap som är nödvändig för att arbeta med graviditetsförluster är en god kommunikationsförmåga. Utöver en god kommunikation är det viktigt att respektera patientens tempo i kommunikationen och att våga stanna upp i tystnad. En annan egenskap var sjuksköterskors empatiska förmåga. Empatin visas genom lyssnande och stöd. Sandman & Kjellström (2018) beskriver att empati innebär att kunna förstå och sätta sig in i en persons känslor i olika situationer och ses från andra parters perspektiv. Genom att förstå en annan persons perspektiv kan en empatisk förståelse uppstå. Förutsättningar för empati är att kunna skilja på egna känslor och den andras känslor. Viktigt att poängtera att visa empati innebär inte att känna likadant eller visa medlidande. Förmågan att visa empati kan i många fall stärkas över tid med övning (Sandman & Kjellström, 2018).

Enligt Haribhai-Thompson m.fl. (2022) kan empati beskrivas som en tvåstegsprocess, förstå och uppskatta en persons känslor och sedan kommunicera förståelsen tillbaka på ett stödjande sätt. Kommunikation är en central del i empatin och beskrivs som kärnan i all kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Vidare beskriver Martins m.fl. (2023) att sjuksköterskorna bör visa att dom finns tillgängliga för emotionellt stöd även fast patienten vid tidpunkten inte är intresserad av det. Sjuksköterskorna strävar efter att ge en tydlig personcentrerad vård mot patienterna där vården anpassas utifrån patientens personlighet och behov (Martins m.fl., 2023). Svensk sjuksköterskeförening (2024) beskriver att ge personcentrerad vård innebär att ge rum för förståelse samt att se patienten som en unik individ. Se patientens individuella resurser, behov, förväntningar och värderingar. För att uppnå en god och säker vård ska vården ske utifrån patientens berättelse med en gemensam öppenhet för varandra.

Forsberg (2016) tar upp olika kompetenser som krävs för att kunna ge en personcentrerad vård. För att ge personcentrerad vård är förutsättningarna för sjuksköterskornas egenskaper viktigt. Sjuksköterskor ska vara professionella, kompetenta och engagerade i sitt jobb. Sjuksköterskorna

ska även ha utvecklat mellanmänskliga förmågor, tydligt uttrycka värderingar och ha en självförståelse. Vidare bör vårdmiljön bland personalen i vårdteamet vara av bredd med olika kompetenser samt ha en kultur där nytänkande är accepterat och personalen inte upplever rädsla för utveckling. Vårdandet av patienten ska drivas utifrån patientens värderingar där personalen är närvarande och tillfredsställer patientens fysiska och mentala behov genom att skapa delaktighet. Personalen ser även över att makten fördelas mellan patient och personal. Utifrån en personcentrerad vård genom delaktighet i vården, känsla av välbefinnande och att skapa en läkande miljö kan ett positivt resultat av vården ske (Forsberg, 2016).

PROBLEMFORMULERING

Missfall är en vanlig komplikation under den tidiga graviditeten. En betydande andel av alla graviditeter slutar i ett missfall vilket gör det till en erfarenhet som flertal kvinnor genomgår. Missfall kan medföra både fysiska och psykiska konsekvenser. En bristande förståelse av dessa kvinnor i sjukvården kan påverka möjligheten att ge en adekvat och personcentrerad vård.
För att fördjupa förståelsen av missfallets betydelse för kvinnor finns ett behov av att sammanställa befintlig forskning om deras upplevelser. En litteraturöversikt möjliggör en samlad och fördjupad bild av kvinnors upplevelser av missfall och kan därigenom bidra till ökad kunskap och ett förbättrat och personcentrerat bemötande.

SYFTE

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av missfall.

TEORETISK REFERENSRAM

I Katie Erikssons omvårdnadsteori (2015) intar lidandet en central och grundläggande position. Hon beskriver lidande som en del av människans existens och som en erfarenhet som berör hela människan som kropp, själ och ande. Lidande är enligt Eriksson (2015) inte enbart kopplat till fysisk smärta eller sjukdom utan handlar om en djupare upplevelse av att vara hotad, sårad eller berövad. Det kan röra sig om förlust av hälsa, självständighet, relationer eller mening. Lidande är däremot något existentiellt som angår människans värdighet och identitet. Samtidigt menar

Eriksson (2015) att lidande inte enbart är negativt det kan också innebära en möjlighet till utveckling och fördjupad förståelse av livet om människan får stöd i att uthärda och bearbeta det.

I vårdandets sammanhang blir det därför avgörande att vårdaren uppmärksammar och bekräftar patientens lidande. Att lindra lidande är enligt Eriksson (2015) kärnan i vårdandet. Detta kräver ett etiskt förhållningssätt där patientens värdighet respekteras och där vårdaren möter människan med närvaro, öppenhet och medkänsla. Om lidandet inte blir sett eller tas på allvar riskerar det att förvärras. Vårdandets uppgift blir därmed inte enbart att behandla sjukdom utan att möta människan i hennes totala livssituation (Eriksson, 2015).

Eriksson (2015) beskriver tre former av lidande som kan aktualiseras i vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Dessa former är analytiska begrepp som hjälper till att synliggöra olika dimensioner av patientens erfarenheter men i verkligheten kan de samverka och överlappa varandra.

Sjukdomslidande är det lidande som uppstår i relation till sjukdom och medicinsk behandling. Det innefattar både kroppslig smärta och andra fysiska symtom såsom trötthet, illamående eller funktionsnedsättning. Sjukdomslidandet rymmer även psykiska och emotionella reaktioner exempelvis oro inför en diagnos, rädsla för framtiden eller ångest inför behandling. Att bli sjuk kan innebära en förlust av kontroll och självständighet vilket i sig kan skapa lidande. Även medicinska åtgärder som operationer, undersökningar och behandlingar kan orsaka ytterligare smärta och obehag. Eriksson (2015) betonar att sjukdomslidande inte enbart handlar om det mätbara och kroppsliga utan om hur människan upplever sin situation. Vårdaren behöver därför vara lyhörd för patientens subjektiva erfarenheter av sjukdom (Eriksson, 2015).

Vårdlidande är det lidande som uppstår till följd av brister i vården eller i mötet mellan patient och vårdpersonal. De kan handla om att patienten känner sig kränkt, ignorerad eller reducerad till en diagnos snarare än att bli sedd som en hel människa. Bristande information, nonchalant bemötande eller maktutövning kan bidra till att patientens värdighet hotas. Eriksson (2015) framhåller att vårdlidande är särskilt problematiskt eftersom det är ett lidande som vården själv orsakar och som därmed i många fall hade kunnat undvikas. När vården inte präglas av respekt och etisk medvetenhet riskerar den att förstärka patientens utsatthet istället för att lindra den. Att förebygga vårdlidande innebär därför att ständigt reflektera över makt, ansvar och bemötande i vårdsituationen (Eriksson, 2015).

Livslidande är det lidande som är kopplat till människans hela livssituation och existens. Det kan betyda att sjukdom eller andra livshändelser förändrar förutsättningarna för livet. Förlusten av hälsa kan innebära en förlust av framtidsdrömmar, roller eller relationer. Livslidande kan också handla om existentiella frågor kring mening, skuld, ensamhet och död. Detta lidande sträcker sig bortom det rent medicinska och berör människans innersta upplevelse av att vara människa. I mötet med livslidande behöver vårdaren skapa utrymme för samtal och reflektion och våga stanna kvar i det svåra utan att förenkla eller bortförklara (Eriksson, 2015).

Genom att uppmärksamma sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande synliggör Eriksson (2015) hur mångdimensionellt lidandet är. Vårdandets uppgift blir att lindra lidande i alla dessa dimensioner och att värna patientens värdighet. Det innebär att se människan bakom sjukdomen, att undvika handlingar som orsakar ytterligare lidande och att stödja patienten i att finna mening i svåra situationer. På så sätt blir lindrandet av lidande inte enbart en praktisk uppgift utan ett etiskt och existentiellt ansvar som genomsyrar hela omvårdnaden (Eriksson, 2015).

Teorin valdes eftersom studien handlar om kvinnors upplevelser av missfall vilket innefattar både fysiskt, känslomässigt och existentiellt lidande. Erikssons begrepp som livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande kommer att användas för att förstå och tolka litteraturöversiktens resultat. Teorin hjälper oss att belysa hur vården kan möta kvinnors behov och lindra deras lidande genom stöd och ett respektfullt bemötande.

METOD

Metoden som användes var en litteraturöversikt. Litteraturöversikt innebär att data systematiskt samlas in och beskriver den kunskap som redan finns inom det valda området. Inom omvårdnadsvetenskap används litteraturöversikt för att synliggöra centrala problem och fenomen i sjuksköterskans profession och för att bidra till en vård som grundas på evidens (Friberg, 2022).

DATAINSAMLING

Inklusionkriterier i datasökningen var kvinnor i åldern mellan 19–44 år. Åldern var begränsad med anpassning till kvinnans reproduktiva åldersspann. En annan inklusionkriterie var vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ studiedesign. Enligt Friberg (2022) bygger originalartiklar på empiriska studier där data samlas in direkt till exempel genom intervjuer,

observationer eller enkäter. Kvalitativ metod enligt Billhult & Henricson (2017) används för att förstå människors upplevelser och erfarenheter. Kvalitativa studier ansågs vara relevanta utifrån att besvara syftet. Artiklar som tar upp partners eller andra anhörigas upplevelser av kvinnans missfall exkluderades från litteraturöversikten.

Författarna valde att söka i två databaser, Cinahl Complete och PubMed. Databaserna är inriktade på omvårdnadsvetenskap och medicin och hälsa. Databaserna valdes på grund av ett brett och kvalitetsgranskat urval av vetenskapliga publikationer vilket är relevant för sjuksköterskans kunskapsområde (Östlundh, 2022).

Begränsningar som användes i båda databaserna var årtal samt språk. Språket var begränsat till engelska och studierna ska ha publicerats mellan 2019–01 och 2026–01. I databasen Cinahl Complete användes även begränsningen Peer Reviewed. I PubMed finns ej denna begränsning tillgänglig därav har en manuell granskning genomförts för att säkerställa att artiklarna som valdes ut är Peer Reviewed. Enligt Östlundh (2022) används Peer Reviewed för att säkerställa att endast vetenskapliga artiklar från granskade tidskrifter inkluderas i sökningen. Användning av funktionen leder till att material som inte genomgått vetenskaplig granskning filtreras bort och artiklar med högre akademisk trovärdighet föreligger.

När databassökningen gjordes inkluderades både ämnesord och fritextord. Sökorden valdes utifrån syftet. Ordet missfall söktes med hjälp av MeSH termen "Abortion, spontaneous". Ordet upplevelse är inget ämnesord och därmed användes fritextsökning. Fritextordet som valdes var "experience*". Ordet söktes med en trunkering * för att säkerställa olika versioner av begreppet samt få ett breddare resultat (Östlundh, 2022). Orden kombinerades utifrån Boolesk sökteknik. Söktekniken innebär användning av operatorer AND och OR för att bredda och avgränsa sökresultat i databaser (Östlund, 2022). Följande sökning gjordes i båda databaserna, "Abortion, spontaneous" AND "experience*".

Under urvalsprocessen av resultatartiklarna granskades artiklarnas titel först. Om artikelns titel var relevant för ämnet lästes artikelns abstract. Uppfylldes inklusionkriterierna samt att abstract bedömdes vara relevant för syftet lästes artiklarna i sin helhet. Sökningen gav 411 träffar på PubMed och 175 på Cinahl. 26 abstracts och sex artiklar läste i PubMed. I Cinahl lästes 22 abstract och åtta artiklar i sin helhet. Totalt lästes 48 abstract och 14 artiklar i sin helhet innan det tio resultatartiklarna valdes ut, se bilaga 1. Fyra artiklar från Cinahl valdes bort efter att ha lästs i

sin helhet på grund av att författarna ansåg att artikeln ej besvarade syftet. Resultatartiklarna presenteras i bilaga 2. I bilagan presenteras artiklarnas syfte, metod, urval samt det övergripande resultatet kortfattat.

De artiklarna som valdes ut genomgick en kvalitetsgranskning för kvalitativa studier med hjälp av Fribergs granskningsfrågor (2022). Totalt ställdes 14 olika frågor för att granska om artikeln håller en vetenskaplig nivå och har en relevans för området. Granskningen gjordes först individuellt för att sedan jämföras gemensamt. Vid eventuella differenser diskuterade författarna tills dem var eniga. Exempel på frågor som ställdes var om etiskt resonemang fanns, en tydlig problemformulering presenteras eller att en metoddiskussion fanns. Utifrån granskningsfrågorna klassificerades sedan artiklarna i hög, medel eller låg kvalitet. Om en artikel hade majoritet hög som svar på frågorna gavs artikeln en hög kvalitet. Var svaren övervägande höga och resterande medel gavs en medel kvalitet. Om artikeln fick få tal höga och övervägande låg och medel gavs en låg kvalitet. Endast det artiklar med hög eller medel kvalitet valdes ut. Efter kvalitetsgranskningen inkluderades alla artiklar. Åtta artiklar av hög kvalitet samt två artiklar av medel kvalitet. Kvalitetsgranskningen presenteras i bilaga 3.

DATAANALYS

Dataanalysens genomfördes enligt Fribergs (2022) fyra analyssteg. Det första steget innebar att de utvalda artiklarna granskades flera gånger för att få en helhetsförståelse för innehåll och sammanhang. För att underlätta det fortsatta analysarbetet sammanfattades studien i en kortare text och centrala delar lyftes fram. Artiklarna lästes och sedan sammanfattades centrala delar individuellt för att sedan diskutera fram till en samsyn. I det andra steget dokumenterades artiklarnas syfte, metod och centrala resultat i en översiktstabell. Tabellen fungerade som ett stöd för att skapa struktur och en tydlig överblick över materialet. Tabellen blev sedan den grund för litteraturöversiktens resultatartiklar (se bilaga 2). I det tredje steget identifierades artiklarnas likheter och skillnader med hjälp av färgkodning. Skillnader och likheter i artiklarnas resultat färgkodades med fokus på att identifiera mönster och variationer. Utifrån färgkodningen kunde olika temaområden identifieras. Det fjärde och avslutande steget innebar att analysens utfall sammanställdes. I detta steg grupperades materialet som behandlar liknande aspekter under passande rubriker utifrån den färgkodning som hade gjorts. De tydliga kategorier som skapades gav en strukturerad bild av det som framkommit. Utifrån dessa rubriker kunde tre nya temaområden skapas.

AI har använts för språkgranskning samt lexikon och andra översättningsverktyg för att översätta specifika ord till svenska.

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN

Enligt Kjellström (2017) tar forskningsetik ställning till att respektera alla individers värde och rättigheter samt bevara alla livsformer. En reflektion har gjorts över de värden som kommer till uttryck i forskningens olika delar för att kunna tillämpa etiska principer. Inför litteraturöversiktens arbete har kunskap inhämtats om de normer, värderingar och riktlinjer som finns inom forskarsamhället genom att läsa Nürnbergs kodexen samt Helsingforsdeklarationen (Kjellström, 2017).

I litteraturöversikten var det krav på etiska godkännande i resultatartiklarna. Etisk godkännande innebär att studien har granskats och godkänts av en oberoende etikprövningsinstans innan datainsamlingen påbörjades. Syftet med granskningen är att säkerställa att forskning genomförs med respekt för människovärdet samt att deltagarnas rättigheter, säkerhet och personliga integritet skyddas. Etiskt godkännande stärker studiens trovärdighet och visar att forskningen har genomförts i enlighet med gällande forskningsetiska riktlinjer (Kjellström, 2017). Vissa artiklar hade en tydlig etisk beskrivning i studien och ett etiskt godkännande medan i andra studier var det otydligt eller utelämnades helt. I de studier där detta var otydligt eller utelämnades gjordes en manuell granskning i den tidskrift som studien var publicerad i. Tidskriften granskades och en försäkran styrktes att etiska krav fanns på alla studier som publicerades.

Grundvärdena hederlighet och ärlighet följdes samt god forskningssed genom att inte plagiera, manipulera eller förvränga resultat (Vetenskapsrådet, 2024; Kjellström, 2017). Under arbetets gång diskuterade författarna om att inte låta egna förutfattade åsikter komma i vägen för att inte manipulera eller förvränga metoder och resultat i artiklarna (Kjellström, 2017). En medvetenhet om den individuella förförståelsen har beaktats under arbetets gång. För att minimera risken för partiskhet har författarna försökt hålla sig objektiva. Artiklarna lästes individuellt för att sedan diskuteras fram till en gemensam samsyn (Dahlborg, 2022). Grunden för arbetet har utgått från Vetenskapsrådets (2024) fyra grundprinciper att göra gott, att inte skada, att respektera självbestämmande och att upprätthålla rättvisa. Under arbetets gång har en hög forskningsetisk kvalitet strävats efter.

RESULTAT

Litteraturöversikten omfattades av tio vetenskapliga originalartiklar med en kvalitativ studiedesign. Artiklarna har en stor geografisk spridning och omfattar artiklar från olika delar av världen med olika typer av vårdmiljöer och förutsättningar. Deltagarna utgörs av enbart kvinnor som upplevt minst ett missfall under deras livstid. I analysen framkom tre huvudteman med respektive underteman. Dessa presenteras i tabellen nedan.

Tabell 1.

Huvudteman			
	Emotionellt lidande	**Brister i vården**	**Att leva vidare med förlusten**
Underteman	Emotionell turbulens	Bemötande	Utmaningar
	Förlust och skam	Information	Erkännande av förlusten
	Sorg och rädsla		Meningsskapande och hopp

Emotionellt lidande

Kvinnor som drabbats av ett missfall beskrev flera olika typer av emotionella känslor och besvär. De psykiska besvär och emotionella känslorna var i en betydligt större utsträckning än dem fysiska. De få fysiska besvär som tas upp är fysisk smärta, blödningar, hormonella biverkningar och kroppsliga förändringar (Crous m.fl., 2025; Furtado-Eraso m.fl., 2024; Lariviére-Bastien m.fl., 2019). Det emotionella känslorna som upplevdes var flertal och presenteras med tre underteman.

Emotionell turbulens

Kvinnorna uppgav att dem upplevde flera olika emotionella känslor under en kort period. Olika metaforer som en emotionell turbulens, berg- och dalbana och storm användes för att förklara deras upplevelser av känslor. Deras metaforer syftar till hur känslorna kunde variera mellan hopp och besvikelse och att inte veta vilka emotionella känslor som upplevs vid tillfället (Furtado-Eraso m.fl., 2024; Punches m.fl., 2019, Özcentin & Boz, 2022). Denna emotionella turbulens

kunde även bli påverkad av den väntetid som kvinnorna tvingas gå igenom från att det har sökt vård tills att diagnosen missfall var fastställd. De beskrev att väntan var plågsam samt fylld med oro, ängslan, frustration och irritation. En längre väntetid hade även negativa konsekvenser på kvinnornas mående och syn på sjukvården (Lariviére-Bastien m.fl., 2019; Lockett & Mash, 2024; Punches m.fl., 2019, Özcentin & Boz, 2022).

Förlust och skam

I samband med att kvinnorna har fått missfallet bekräftat och diagnostiserats upplevdes en förlust av framtiden. Kvinnornas förväntningar och drömmar om framtiden krossades på ett ögonblick. De moderskap som de hade längtat efter och det livsplaner som hade planerats raserades. Kvar lämnades de med känslor som chock, tomhet och besvikelse (Bellhouse m.fl., 2019; Boakye m.fl., 2025; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Furtado-Eraso m.fl., 2024; Punches m.fl., 2019, Özcentin & Boz, 2022). En annan känsla som var genomgående var kvinnornas egna skuldbeläggande och känslan av skam och misslyckande. Kvinnorna var desperata efter att hitta anledningar till att missfallet hade skett och många skyllde på sig själva samt hade tankar kring om det var deras mående eller livsstil som bidrog till den spontana aborten (Bellhouse m.fl., 2019; Boakye m.fl., 2025; Levitan m.fl., 2025; Punches m.fl., 2019). Känslan av misslyckande och skam var även kopplat till familjens reaktioner och/eller kulturella och samhällets förväntningar på kvinnors fertilitet (Boakye m.fl., 2025; Levitan m.fl., 2025).

Sorg och rädsla

Att drabbas av ett missfall var en sorg för dem flesta. Sorgen var påtaglig och hanterades på olika sätt. Ett vanligt sätt för kvinnorna att kunna hantera sorgen och kunna sörja är att isolera sig från omvärlden. Kvinnorna valde oftast självmant att isolera sig för att kunna få sörja och hantera sorgen på egen hand. Kvinnorna upplevde att andra personer inte förstod deras situation och därmed inte bidrog till att kunna gå vidare i sorgeprocessen. Genom isolering kunde de undvika att samtala om deras traumatiska upplevelse och där med även känna en större lätthet att gå vidare (Bellhouse m.fl., 2019; Boakye m.fl., 2025; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Furtado-Eraso m.fl., 2024; Özcentin & Boz, 2022). Andra upplevelser var ensamhet. Ensamheten kunde upplevas efter känslan av att vårdpersonalen inte visade omtanke för patientens situation. Ensamheten kopplades till ett bristande stöd och tröst från främst vårdpersonal men även familj på grund av kulturella aspekter (Crous m.fl., 2025; Levitan m.fl., 2025; Lockett & Mash, 2024). En annan genomgående känsla hos kvinnorna var rädsla. Rädslan kunde visa sig på olika tillfällen under situationen. De beskrev en rädsla inför framtida graviditeter och rädsla för aldrig kunna få

ett barn (Bellhouse m.fl., 2019; Boakye m.fl., 2025; Özcentin & Boz, 2022). Rädslan kunde även tillkänna ges under tiden missfallet skedde. Fram till att diagnosen hade fastställts kände flera kvinnor en rädsla för vad som pågick. Känslan av att något är fel samtidigt som kvinnorna upplever bristande kommunikation samt vårdpersonal som springer fram och tillbaka utan att berätta vad som pågår (Furtado-Eraso m.fl., 2024; Punches m.fl., 2019). Andra situationer kvinnor kunde uppleva rädsla var för den bristande informationen som gavs angående det fysiska och psykiska symtom som kunde uppstå efter ett missfall (Lariviére-Bastien m.fl., 2019), rädsla för omgivningens blickar och tankar (Levitan m.fl., 2025) samt rädsla för sin egen säkerhet på akutmottagningen (Crous m.fl., 2025).

Brister i vården

Flera studier belyser omfattande brister i vården och vårdrelationen i samband med ett missfall som presenteras med två underteman.

Bemötande

Samtliga inkluderade artiklar belyser att vårdpersonalens bemötande hade en avgörande betydelse för kvinnornas upplevelse av vården efter ett missfall. Ett återkommande fynd i flera studier var att empati, respekt, emotionellt stöd och förståelse från vårdpersonalen bidrog till ökad trygghet, välbefinnande och en mer positiv vårdupplevelse (Bellhouse m.fl., 2019; Crous m.fl., 2025; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Furtado-Eraso m.fl., 2024; Lockett & Mash, 2024; Punches m.fl., 2019). När personalen tog sig tid att lyssna, visade omsorg och försökte trösta kvinnorna upplevdes vården som stödjande och underlättade sorgeprocessen. Stöd från specifika yrkesgrupper, såsom sjuksköterskor och psykologer framkom betydelsefullt för kvinnornas upplevelse av vårdkvalitén (Bellhouse m.fl., 2019; Lockett & Mash, 2024). Samtidigt rapporterar samtliga studier negativa erfarenheter kopplade till vårdpersonalens bemötande. Bristande empati, likgiltighet, låg sensitivitet och avvisande eller dömande attityder beskrevs genomgående och ledde till känslor som otrygghet, misstro och förlorat förtroende för vården (Bellhouse m.fl., 2019; Crous m.fl., 2025; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Furtado-Eraso m.fl., 2024; Lockett & Mash, 2024; Punches m.fl., 2019). Flera deltagare upplevde även att de blev ignorerade eller avfärdade, vilket minskade upplevelsen av vårdkvalitén.

Information

Samtliga artiklar visade att deltagarna upplevde bristande information som en central brist i vården (Bellhouse m.fl., 2019; Crous m.fl., 2025; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Furtado-Eraso

m.fl., 2024; Lockett & Mash, 2024; Punches m.fl., 2019). Informationen beskrevs ofta som ofullständig, otydlig eller helt utebliven vilket ledde till förvirring, oro, rädsla och känslor av otrygghet. Kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckliga svar på sina frågor och saknade förståelse för vad som hände i samband med missfallet, både medicinskt och emotionellt. Flera studier visar att bristande information gällande diagnostik, behandlingsalternativ, väntetider och provsvar skapade frustration och ökade kvinnornas psykiska lidande (Bellhouse m.fl., 2019; Lariviére-Bastien m.fl., 2019 ; Lockett & Mash, 2024). Avsaknad av förberedande information inför undersökningar och behandlingar bidrog till att kvinnorna kände sig oförberedda på smärta, blödningar och utstötning av fostret vilket i vissa fall ledde till panik, återbesök i vården och traumatiska upplevelser (Crous m.fl., 2025; Lariviére-Bastien m.fl., 2019). Tydlig information och delaktighet, där muntlig information som kompletterades med skriftligt material samt korta väntetider upplevdes positivt och stärkande (Furtado-Eraso m.fl., 2024; Lockett & Mash, 2024). En annan återkommande brist var avsaknad av uppföljning och kontinuerligt stöd efter missfallet (Bellhouse m.fl., 2019; Crous m.fl., 2025; Furtado-Eraso m.fl., 2024; Lariviére-Bastien m.fl., 2019). Kvinnorna upplevde att vårdkontakten avslutades abrupt, vilket försvårade sorgebearbetningen och bidrog till känslor av ensamhet och övergivenhet. Brist på information om psykiska reaktioner efter missfallet, egenvård, hormonella förändringar och framtida fertilitet framkom också som gemensamma behov i flera studier (Bellhouse m.fl., 2019; Boakye m.fl., 2025; Lariviére-Bastien m.fl., 2019; Crous m.fl., 2025; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Furtado-Eraso m.fl., 2024; Levitan m.fl., 2025).

Att leva vidare med förlusten

Flera studier belyser att en graviditetsförlust påverkade kvinnornas liv långt efter den akuta fasen och att processen att leva vidare med förlusten av en graviditet präglades av relationella, existentiella och kulturella faktorer (Boakye m.fl., 2025; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Furtado-Eraso m.fl., 2024; Levitan m.fl., 2025; Özcentin & Boz, 2022). Förlusten krävde en omställning i både relationer och självförståelse där stöd, erkännande och meningsskapande framkom som centrala komponenter i den långsiktiga bearbetningen. Långsiktiga konsekvenser efter ett missfall var psykisk ohälsa i form av nedstämdhet, depression och ångest (Bellhouse m.fl., 2019; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Furtado-Eraso m.fl., 2024).

Utmaningar

Flera studier visar att relationen till partnern spelade en avgörande men komplex roll i kvinnornas sorgeprocess. Kvinnorna beskrev att makar ofta sörjde i olika takt och på olika sätt vilket i vissa fall ledde till känslomässig distans, missförstånd och svårigheter att ge och ta emot stöd (Furtado-Eraso m.fl., 2024; Levitan m.fl., 2025). I vissa sammanhang tog partnern rollen som den "starka" vilket upplevdes som både skyddande och hindrande för kvinnornas möjlighet till emotionell närhet (Levitan m.fl., 2025). Religiösa och kulturella normer kunde ytterligare påverka relationen exempelvis genom regler som begränsade fysisk närhet efter förlusten och därmed minskade möjligheterna till tröst och intimitet (Levitan m.fl., 2025). Samtidigt framkom att partnern och den närmsta familjen ofta utgjorde ett viktigt stöd särskilt när sorgen kunde delas och erkännas gemensamt (Furtado-Eraso m.fl., 2024; Boakye m.fl., 2025).

Erkännande av förlusten

Ett genomgående fynd var kvinnornas behov av att få förlusten erkänd både inom relationer och i ett bredare socialt sammanhang. Möjligheten att se barnet, namnge det eller utföra ritualer beskrevs som betydelsefulla handlingar som underlättade acceptans och bearbetning (Furtado-Eraso m.fl., 2024; Özcentin & Boz, 2022). Kvinnorna uttryckte även en stark vilja att minnas sitt barn och att inte låta förlusten bli osynlig eller bortglömd. De kunde även handla om att hedra barnet genom en minnesceremoni eller minnessymbol (Bellhouse m.fl., 2019; Özcentin & Boz, 2022). När omgivningen saknade förståelse eller uppmuntrade kvinnorna att snabbt "gå vidare" upplevdes detta som hindrande för sorgeprocessen och bidrog till att vissa valde att tiga om sin förlust (Levitan m.fl., 2025). Behovet av utrymme för sorg och rätten att få sörja i egen takt framkom som centralt i flera studier (Boakye m.fl., 2025; Lariviére-Bastien m.fl., 2019; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Furtado-Eraso m.fl., 2024; Levitan m.fl., 2025).

Meningsskapande och hopp

Flera kvinnor beskrev hur spiritualitet, religion och kulturella föreställningar fungerade som centrala resurser för att skapa mening i förlusten. Tro och existentiella tolkningar gav tröst, hopp och en möjlighet att förstå det inträffande i ett större sammanhang (Boakye m.fl., 2025; Figueredo-Borda m.fl., 2024; Levitan m.fl., 2025). För vissa kvinnor möjliggjorde detta ett gemensamt meningsskapande tillsammans med partnern medan andra upplevde att kulturella normer samtidigt kunde bidra till tystnad och skam. Utöver familj och tro framkom även betydelsen av professionellt stöd, terapi och kontakt med andra kvinnor som haft liknande erfarenheter. Onlinegrupper och strukturerade stödforum bidrog till en känsla av gemenskap och minskad ensamhet (Boakye m.fl., 2025).

Över tid beskrev flera kvinnor en förändring i hur de förhöll sig till förlusten. Trots kvarstående sorg utvecklades en gradvis acceptans där hopp och hopplöshet kunde samexistera (Figueredo-Borda m.fl., 2024; Özcentin & Boz, 2022). Hoppet beskrevs inte som ett avslut på sorgen utan som en möjlig väg framåt där vissa kvinnor började se framtiden med större öppenhet och vågade dela sina erfarenheter med andra (Levitan m.fl., 2025). För vissa kvinnor uppfattades en framtida graviditet som ett sätt att återge livet mening och lindra smärtan medan andra betonade vikten av att först få bearbeta förlusten fullt ut (Figueredo-Borda m.fl., 2024).

DISKUSSION

METODDISKUSSION

I arbetet valdes en litteraturöversikt som metod för att undersöka kvinnors upplevelser av missfall då forskningsfrågan rörde erfarenheter och upplevelser som redan belysts i tidigare studier. Metoden möjliggjorde en samlad analys av befintlig forskning och gav förutsättningar för att identifiera återkommande mönster och variationer i kvinnors erfarenheter (Friberg, 2022). En begränsning med detta metodval är att resultatet påverkas av hur tidigare forskning har genomförts och rapporterats vilket innebär att viktiga perspektiv kan saknas om de inte studerats i tidigare litteratur. Inklusionskriterierna begränsades till kvinnor i ålder 19–44 år vilket motiverades av fokus på kvinnans reproduktiva ålder. Avgränsningen bidrog till ett mer enhetligt material men kan även ha lett till att erfarenheter från kvinnor utanför detta åldersspann exkluderades. Detta kan ses som en metodologisk begränsning då upplevelser av missfall även förekommer i andra åldersgrupper. Valet av att exkludera partners eller andra anhörigas upplevelser styrks av vårt syfte. Syftet med litteraturöversikten är att belysa kvinnors upplevelser av missfall. Genom att avgränsa fokuset på kvinnor kan en mer djupgående bild presenteras av deras behov av stöd. Detta leder samtidigt till en begränsning av litteraturöversikten. Begränsningen kan innebära att vi riskerar att påverka arbetets helhetsbild då kvinnan oftast interagerar med sin partner eller annan anhörig. Exkludering kan även påverka den sociala upplevelsen eftersom partner och anhöriga kan påverka hur kvinnor hanterar det emotionella lidandet och återhämtningen efter ett missfall.

Avgränsningen till kvalitativa studier gjordes för att få tillgång till kvinnors egna berättelser och tolkningar av sina upplevelser. Detta val gav ett djup i materialet som bedömdes nödvändigt för att besvara syftet. Samtidigt innebar avgränsningen att studier med andra metodansatser exkluderades vilket kan ha begränsat bredden i kunskapsunderlaget. Kvantitativa studier hade exempelvis kunnat bidra med ytterligare perspektiv kring hur vanligt förekommande vissa upplevelser är (Billhult & Henricson, 2017). Datainsamlingen genomfördes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Användningen av två databaser ökade sannolikheten att identifiera relevanta studier men valet kan samtidigt ha inneburit att artiklar publicerade i andra databaser inte inkluderades. Detta kan ha påverkat resultatets omfattning och variation. Språk- och tidsbegränsningar till engelskspråkiga artiklar publicerade mellan 2019 och 2026 genomfördes för att inkludera aktuell forskning. Detta stärker studiens relevans men innebär samtidigt en risk för att äldre studier eller studier publicerade på andra språk inte uppmärksammades. Eftersom engelska inte är författarnas modersmål finns även en risk för feltolkningar även om denna risk minskades genom användning av lexikon och översättningsverktyg. AI-verktyg användes som stöd för språkgranskning samt vid översättning av enstaka ord. Detta underlättade arbetet genom att få ett extra stöd vid stavning och grammatik samt en korrekt översättning av specifika engelska ord. Risken med AI användning vid översättning är att orden ej översätts korrekt därför valdes engelsk-svenskt lexikon att kompletteras med för att kunna få flera alternativ och jämföra olika ord. Utifrån det kunde det svenska ordet som speglar det engelska ordet mest ändamålsenligt väljas ut. Trots stöd från AI verktyg som kunde underlätta arbetet var det viktigt att behålla ett kritiskt förhållningssätt samt en öppen kommunikation mellan varandra för att undvika eventuella felaktigheter.

Sökstrategin utformades med både ämnesord och fritextord för att fånga studier som använde olika begrepp för missfall och upplevelser. Detta ökade möjligheten att identifiera relevanta artiklar, dock kan valet av specifika sökord påverka vilka studier som inkluderades. Studier som använde alternativa formuleringar eller begrepp kan därmed ha uteslutits vilket kan ha påverkat resultatets innehåll. Urvalsprocessen genomfördes stegvis genom granskning av titlar, abstract och fulltexter. Arbetet utfördes av båda författarna vilket minskade risken för att relevanta studier sorterades bort på felaktiga grunder vilket är en styrka i arbetet. Trots detta finns alltid en risk för snedvridet urval då bedömningen av relevans i viss mån är subjektiv. Antalet inkluderade artiklar blev relativt begränsat vilket kan ha påverkat möjligheten att fånga hela bredden av kvinnors upplevelser. Kvalitetsgranskningen genomfördes med stöd av Fribergs (2022) granskningsfrågor för kvalitativa studier. Granskningen skedde först individuellt och därefter gemensamt vilket

bidrog till att identifiera eventuella skillnader i bedömningen och öka tillförlitligheten. Att även artiklar av medelkvalitet inkluderades kan ha påverkat studiens kvalitet men bedöms nödvändigt för att inte exkludera relevant forskning inom ett begränsat forskningsfält. Dataanalysen följde Fribergs (2022) fyrstegsmodell vilket gav en tydlig struktur i analysarbetet. Genom att läsa och sammanfatta artiklarna enskilt innan gemensam analys minskade risken för att enskilda tolkningar skulle dominera. Samtidigt finns en risk att författarnas tidigare kunskap och förförståelse påverkade analysen, trots medveten reflektion och återkommande diskussioner under arbetets gång.

Samarbetet mellan författarna har varit kontinuerligt och fungerat obehindrat genom hela processen. Författarna var tydliga med varandra från start att en öppen kommunikation är viktig för att undvika eventuella konflikter. Arbetsuppgifterna fördelades jämt och varje steg i metod och analys diskuterades gemensamt. Detta bidrog till en ökad noggrannhet men det kan även ha inneburit att gemensamma tolkningar förstärktes på bekostnad av alternativa perspektiv.

RESULTATDISKUSSION

Litteraturöversiktens resultat visade att missfall innebär ett omfattande och mångdimensionellt lidande för kvinnor. Resultatet visade att de emotionella reaktionerna var framträdande och ofta mer dominerande än de fysiska symtomen. Kvinnorna beskrev sorg, skuld, skam, rädsla, ensamhet och en förlust av framtidsdrömmar. Resultatet visade även att vårdpersonalens bemötande hade en avgörande betydelse för hur situationen upplevdes. Empati, tydlig kommunikation och delaktighet skapade trygghet medan bristande information och avvisande attityder fördjupade lidandet. Resultatet visar på att kvinnorna utsätts för livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande utifrån Katie Erikssons (2015) teori.

Ett återkommande fynd var att bristande empati och förståelse från vårdpersonalen bidrog till minskad trygghet och en negativ vårdupplevelse vid missfall. I en annan studie av Bailey m.fl. (2019) betonas vikten av att bristande empati i bemötandet från vårdpersonalen var mest påfrestade för kvinnorna.

Sjuksköterskor ska enligt ICN:s etiska kod (2021) bemöta patienter med empati. Utmaningar med ett empatisk bemötande kan vara svårigheter med att förstå skillnaden mellan empati och medlidande. Enligt Sandman & Kjellström (2018) innebär empati att inte känna samma känslor

eller vara medlidande med patienten. Detta kan vara en utmaning för vårdpersonalen att ge emotionellt stöd med empati om skillnaden inte är tydlig. Risken med empatisk bemötande blir även svårigheten att skilja på att vara privat och personlig i vårdmötet. Vårdpersonalen kan ge ett empatiskt stöd utifrån tidigare personliga erfarenheter men det kan leda till en svår balans mellan privatliv och profession. En annan svårighet kan vara personalens medvetna val att inte ha ett empatisk bemötande för att undvika en egen inre känslomässig konflikt. Förmågan att visa empati kan övas upp med tiden. Detta indikerar att det finns ett ökat behov av mer utbildning för vårdpersonalen i empatisk bemötande. Ett sätt för att utveckla empatiskt bemötande är samtalsträning på fenomenologisk grund. Bullington (2018) tar upp empatiträning som en del av samtalsträning på fenomenologisk grund. Empatiträningen strävar efter en ökad förståelse för mellanmänskliga relationer samt öka den empatiska förmågan. Syftet med empatiträningen är att fokusera på patientens berättelse, främja reflektion och skapa en förståelse i samtal mellan patient och sjuksköterska (Bullington, 2018).

I resultatet beskrev även kvinnorna ett bristande emotionellt stöd samt bristande information. Den bristande informationen framkom extra påtagligt från första vårdkontakt till att diagnosen missfall förmedlades. Upplevelserna kopplas till att kommunikationen mellan patient och vårdpersonal inte har varit fullständig och därmed stärks kvinnornas känslor av oro och rädsla.

Situationen riskerar att patienten ses mer som en diagnos än människa utifrån vårdpersonalens ögon. Vårdandets uppgift blir därmed inte enbart att behandla sjukdom, utan att möta människan i hennes totala livssituation. Vårdpersonalen bör uppmärksamma all typ av lidande för att belysa hur komplext det är. Oavsett form på lidande ska vårdpersonalen lindra lidande och respektera patientens värdighet. I resultatet tas det upp flera situationer där kvinnan känner sig ignorerad eller förbisedd. Om lidandet inte blir taget på allvar eller sedd av vården riskerar patienten att förvärra sitt lidande (Eriksson, 2015). Enligt Eriksson (2015) är en vårdkultur där patienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad en central del i att lindra lidandet. En viktig del i att lindra lidandet är att våga möta det vårdlidande som patienten upplever. Genom en vänlig blick, ett ord eller smekning kan det svåraste lidandet lindras för en stund. Dessa kärleksförklaringar behövs fortsätta ges igen till människor som lider för att kunna skapa förutsättningar för att lindra lidandet.

Vårdlidande är problematisk för att lidandet uppkommer på grund av vården och kan i många fall undvikas. Lidandet skulle även kunna undvikas genom att vården sker personcentrerat. Enligt

svensk sjuksköterskeförening (2024) innebär det att varje unik individ och berättelse ses med en gemensam öppenhet för varandra. Personcentrering är en förutsättning för en god och säker vård. Resultatet visar på att en personcentrerad vård inte har tillämpats i alla vårdmöten och därmed äventyrat en god och säker vård.

De negativa upplevelser som kvinnorna beskriver kan leda till en ökad risk för ett negativt förtroende för vården. I en studie av Schout m.fl. (2010) belyses vikten av att ett empatiskt förhållningssätt hos vårdpersonalen påverkar förtroendet för vården positivt. I en annan studie av Bilardi m.fl. (2020) identifieras strukturella hinder som skapar utmaningar för att kunna ge ett emotionellt stöd. Dessa hinder är tidsbrist hos personalen, hög vårdbelastning, brist på utbildning samt brister på riktlinjer för emotionellt stöd vid ett missfall. Enligt Lind (2023) slutar ca 15–25% av alla graviditeter i Sverige i ett missfall. Detta är ett sådant vanligt förekommande medicinskt utfall att riktlinjer och stöd för vårdpersonalen bör utvecklas för att skapa en trygg och positiv upplevelse av vården.

Resultatet visar att kvinnor som genomgått missfall ofta tvingas leva vidare med en komplex förlust som rymmer mer än det rent fysiska. Förlusten handlar inte enbart om graviditeten utan även om en förlorad framtid, krossade förväntningar och en förändrad självbild. Detta kan förstås som ett livslidande där känslor av skuld, ensamhet och existentiell tomhet blir framträdande.

I resultatet framkommer att uppföljande stöd efter missfall ofta är bristfälligt. Planerade återbesök saknas i många fall och uppföljning av kvinnans psykiska mående prioriteras inte. Bakgrunden visar att riktlinjer främst fokuserar på medicinsk behandling och fysiska besvär vid missfall. Rekommendationer kring psykologisk uppföljning är begränsade vilket kan bidra till att ansvaret för fortsatt kontakt i praktiken hamnar på kvinnan själv. Detta riskerar att osynliggöra det emotionella konsekvenser som missfallet medför. Även en annan studie av Farren m.fl. (2020) belyser att kvinnor upplever höga nivåer av ångest, depression samt posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) efter ett missfall. Även om det psykiska lidande minskar över tid återstår ändå kliniska betydelsefulla nivåer i nio månader efter missfallet.

Även i en annan studie av Swanson (1999) betonas vikten av att vård efter ett missfall ger en positiv effekt på kvinnors psykiska mående. Under tidens gång där stöd från vården gavs ökade kvinnornas självkänsla. Samtidigt sågs en minskning av ångest och depression samt emotionella

känslor som förvirring, ilska och personlig betydelse av förlusten. Avsaknaden av tidigt och kontinuerligt stöd kan därför försvåra bearbetningen av förlusten och bidra till att livslidandet fördjupas.

Bailey m.fl. (2019) betonar vikten av fortsatt kontakt med vården under väntan på en ny graviditet eller i början av en efterföljande graviditet. Även om kvinnorna är medvetna om att vårdpersonalen inte kan påverka graviditetens utfall upplevs kontakten som betydelsefull. Den ger en känsla av trygghet och ett forum där oro och bekymmer kan uttryckas. Detta kan förstås i relation till sjukdomslidande där både fysiska och emotionella reaktioner behöver uppmärksammas. Att vara lyhörd för patientens subjektiva erfarenheter är centralt och innefattar även tidigare erfarenheter av missfall som kan påverka hur situationen upplevs. Ur ett personcentrerat perspektiv blir det avgörande att se kvinnan som en unik individ med egna behov, resurser, förväntningar och värderingar. Det är därför angeläget att ge utrymme för patientens berättelse och en öppenhet mellan patient och vårdpersonal för att främja och skapa förtroende. Vården bör anpassas utifrån kvinnans tidigare erfarenheter eftersom dessa kan påverka behovet av stöd. En studie av Bilardi m.fl. (2020) belyser att kvinnor som upplevt ett missfall har högre benägenhet att söka vård än kvinnor som genomgått upprepade missfall. Detta kan tyda på att tidigare erfarenheter påverkar tilliten till vården och viljan att åter söka stöd. Kvinnor som upplevt flera missfall kan ha utvecklat en annan förväntan på vårdens möjlighet att bidra vilket ytterligare understryker vikten av individanpassad vård.

När strukturerad uppföljning och psykologiskt stöd saknas riskerar kvinnors livslidande att fördjupas. I kontrast framträder betydelsen av kontinuitet, empati och personcentrering. En vård som integrerar medicinsk behandling med emotionellt stöd och aktivt ger utrymme för kvinnans berättelse skapar bättre förutsättningar att lindra både livslidande och sjukdomslidande i samband med missfall.

KLINISKA IMPLIKATIONER

Resultatet av litteraturöversikten kan bidra till att vårdpersonal får en fördjupad förförståelse för kvinnors situation. Resultatet kan även bidra till en förståelse för vilka behov och önskemål de kan ha i mötet med vården. Denna kunskap kan användas för att anpassa bemötande och stöd utifrån hur kvinnor kan reagera både fysiskt och psykiskt vid ett missfall. Ett lyhört och individanpassat förhållningssätt kan bidra till att minska negativa hälsoeffekter och stärka

kvinnors välbefinnande. I praktiken innebär detta att vårdpersonalen aktivt lyssnar, bekräftar kvinnans upplevelser av förlusten och undviker att normalisera bort sorgen. Det är även viktigt att ge tydlig och individanpassad information om både det fysiska förloppet och vanliga psykiska reaktioner. Erbjuda återbesök vid missfall anses vara viktigt för att deras psykiska besvär inte ska bort prioriteras. Att skapa en trygghet i vårdsituationen exempelvis genom ett respektfullt bemötande och utrymme för frågor kan ha stor betydelse för kvinnors upplevelser. Att involvera kvinnan i beslut och uppmärksamma behov av närståendestöd kan bidra till ökad känsla av kontroll och delaktighet. Fördjupad förståelse för kvinnors erfarenheter av missfall kan även stärka förtroendet för vården och påverka framtida vårdkontakter. Resultatet är dessutom relevant för verksamhetsutveckling och utbildning av vårdpersonal utifrån den kunskap om kvinnors upplevelser vid missfall. Vikten av att utbilda personal i empatisk bemötande och skapa riktlinjer för hur ett emotionellt stöd kan ges till dessa kvinnor. Kunskapen och vidare utbildningar är av stor vikt för att kunna ge en god omvårdnad i klinisk praxis.

FÖRSLAG FORTSATT FORSKNING

Litteraturöversikten visar på behov av fortsatt forskning inom området missfall. Framtida studier kan med fördel fokusera på vårdpersonalens perspektiv på att möta och hantera kvinnor som drabbats av missfall vilket kan bidra till en ökad förståelse för hela vårdsituationen. Genom att belysa vårdpersonalens erfarenheter kan kunskap utvecklas om vilka utmaningar som finns i det kliniska arbetet och hur stödet till kvinnorna kan förbättras. Vidare kan forskning som inkluderar flera professioner såsom barnmorskor, undersköterskor och kuratorer ge en mer heltäckande bild av vården vid spontana aborter. En multiprofessionell ansats kan synliggöra hur olika yrkesgrupper samverkar och hur deras insatser kan komplettera varandra i mötet med kvinnan. Framtida forskning kan även bidra till utveckling av förbättrade riktlinjer för vård vid missfall där både medicinska och psykosociala aspekter beaktas. För att fördjupa kunskapen kan både kvalitativa och kvantitativa metoder användas exempelvis intervjustudier med vårdpersonal eller enkätstudier som undersöker upplevelser och behov i den kliniska praktiken.

SLUTSATS

Litteraturöversikten visar att kvinnors upplevelser av missfall är komplext och subjektiva där de psykiska och emotionella besvären framträder mer omfattande än de fysiska. Resultatet visar även att många kvinnor lever vidare med förlusten under en längre period ofta präglad av psykisk ohälsa. Vårdens och vårdpersonalens bemötande har stor betydelse för kvinnors upplevelser i samband med missfall. Bristande information samt ett bemötande som präglas av låg empati, bristande förståelse och i vissa fall dömande attityder påverkar kvinnornas välbefinnande negativt. Samtidigt framkommer att ett lyhört, respektfullt och informativt bemötande kan bidra till ökad trygghet och underlätta bearbetningen av förlusten. För att förbättra vården krävs ökad medvetenhet, utbildning samt tydliga riktlinjer för emotionellt stöd inom gynekologisk och obstetrisk vård. Genom sådana insatser kan kvinnors emotionella behov uppmärksammas både i det akuta skedet och tiden efter förlusten.

REFERENSFÖRTECKNING

*artikel inkluderad i resultatet

Al-Alami, Z., Abu-Huwaij, R., Hamadneh, S., & Taybeh, E. (2024). Understanding Miscarriage Prevalence and Risk Factors: Insights from Women in Jordan. *Medicina, 60(7),* 1044. https://doi.org/10.3390/medicina60071044

Bailey, S-L., Boivin, J., Cheong C, Y., Kitson-Reynolds, E., Bailey, C., & Macklon, N. (2019). Hope for the best...but expect the worst: a qualitative study to explore how women with recurrent miscarriage experience the early waiting period of a new pregnancy. *BMJ Open, 9(5)*, e029354. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029354

Bellhouse, C., Temple-Smith J, M., & Bilardi E, J. (2018). "It's just one of those things people don't seem to talk about..." women's experiences of social support following miscarrigae: a qualitative study. *BMD Women's Health, 18(1)*, 176. https://doi.org/10.1186/s12905-018-0672-3

*Bellhouse, C., Temple-Smith J, M., Watson, S., & Bilardi, J. (2019). "The loss was traumatic... some healthcareproviders added to that": Women's experiences of misscarriage. *Women & Birth*, *32(2)*, 137-146. https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1016/j.wombi.2018.06.006

Bilardi E, J., Sharp, G., Payne, S., & Temple-Smith J, M. (2021). The need for improved emotional support: A pilot online survey of Australian women's access to healthcare service and support at the time of miscarriage. *Women and Birth, 34(4)*, 362–369. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.06.011

Billhult, A., Henricson, M. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), *Vetenskaplig teori och metod*: *Från ide till examination inom omvårdnad* (2 uppl., s. 111-120). Studentlitteratur.

*Boakye N, P., Prendergast, N., Obewu Thomas Abanta O., & Mugambi, D. (2025). "I Was Shattered and Broken": Unmasking the Experiences and Responses of Black Canadian to Pragnency Loss. *Canadian Journal of Nursing, 57(3)*, 342-351. https://doi.org/10.1177/08445621251320570

Borgfeldt, C., Sjöblom, I., Strevens, H., & Wangel, A. -M. (2019). *Obstetrik och gynekologi: För sjuksköterskor* (5 uppl.). Studentlitteratur.

Bottomley, C., & Bourne, T. (2009). Diagnosing miscarriage. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, 23(4)*, 463-477. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2009.02.004

Bullington, J. (2018). *Samtalskonst i vården: Samtalsträning för sjuksköterskor på fenomenologisk grund* (1 uppl.). Studentlitteratur.

*Crous, M., Motsohi, T., & Adeniji A, A. (2024). Witzenberg Women's experience of health care after a Miscarriage: A descriptive qualitative study. *African journal of primary health care & family medicin*, *16(1)*, e1-e9. https://doi.org/10.4102/phcfm.v16i1.4581

Dahlborg, E. (2022). Att analysera berättelser (narrativer). I F. Friberg (Red.) *Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten*. (4 uppl., s. 221-233). Studentlitteratur.

Demokakos, P., Linara-Demakakou, E., & Mishra D, G. (2020). Adverse childhood experiences are associated with increased risk of misvarriage in a national population-based cohort study in England. *Human Reproduction, 35(6)*, 1451-1460. https://doi.org/10.1093/humrep/deaa113

Farren, J., Jalmbrant, M., Falconieri, N., Mitchell-Jones, N., Bobdiwala, S., Al-Memar, M., Tapp, S., Van Calster, B., Wynants, L., Timmerman, D., & Bourne, T. (2020). Posttraumatic stress, anxiety and depression following miscarriage and ectopic preganacy: a multicenter, prospective, cohort study. *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 222(4)*, 367.e1-367.e22. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.10.102

Eriksson K. (2015). Den lidande människan. (2 uppl). Liber.

*Figueredo-Borda, N., Ramfrez-Pereira, M., Gaudiano, P., Cracco, C., & Ramos, B. (2024). Experiences of miscarriage: the voice of parents and health professionals. *Omega:*

Journal of Death & Dying, 89(2), 777-794. https://doi.org/10.1177/00302228221085188

Friberg, F. (2022). Att göra en litteraturöversikt av kvantitativ och kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), *Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.* (4 uppl., s. 185-198). Studentlitteratur.

Friberg, F. (2022). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.), *Dags för uppsats*: *vägledning för litteraturbaserade examensarbeten*. (4 uppl., s. 41-56). Studentlitteratur.

Forsberg, A. (2016). *Omvårdnad på akademisk grund: Att utvecklas och ta ansvar* (1 uppl.). Natur & kultur.

*Furtado-Eraso, S., Marín-Fernández, B., & Escalada-Herández, P. (2024). "Perinatal loss, a devastating cyclone": A situation-specific nursing theory. *Journal of nursing scholarship: an offcial publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, 56(5)*, 664-667. https://doi.org/10.1111/jnu.12996

Haribhai-Thompson, J., McBride-Henry, K., Hales, C., & Rook, H. (2022). Understanding of empathetic communication in acute hospital settings: a scoping review. *BMJ Open 12*, e063375. 10.1136/bmjopen-2022-063375

Karolinska institutet. (u.å.). *Svensk MeSH*. Hämtad 2026-02-16, från Svensk MeSH

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henriksson. (Red.). *Vetenskaplig teori och metod: Från ide till examination inom omvårdnad.* (2 uppl., s. 57-80). Studentlitteratur.

*Larivière-Bastien, D., deMontigny, F., & Verdon, C. (2019). Women's Experiences of Miscarriage in the Emergency Department. *Journal of emergency nursing*, *45*(6), 670–676. https://doi.org/10.1016/j.jen.2019.06.008

*Levitan, F., Frei-Landau, R., & Sabar-Ben-Yehoshua, N. (2025). "I Just Needed a Hug": Culturally-Based Disenfranchised Grief of Jewish Ultraorthodox Women

Following Pregnancy Loss. *Omega: Journal of Death & Dying*, *91*(1), 342–360. https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1177/00302228221133864

Lind, T. (2023). *Missfall*. Kunskapsstöd för vårdgivare. Missfall - Kunskapsstöd för vårdgivare

*Lockett, M., & Mash R, J. (2024). Lived experiences of women with spontaneus abortion at a district hospital, South Africa. *South African family practice : offivial journal of the South African Academy of Family Practivce/Primary Care, 66(1)*, e1-e9. https://doi.org/10.4102/safp.v66i1.5917

Martins V, M., Valente A, V., Silva D, A., Ramalho, C., & Costa E, M. (2023). "Death is a sensitive topic when you are surrounded by life": Nurses experiences with pregnancy loss. *Sexual and Reproductive Healthcare. 35(4)*, 100817. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100817

Miscarriage Australia. (2025, 23 maj). *What is miscarriage?*. https://miscarriageaustralia.com.au/understanding-miscarriage/what-is-miscarriage/

*Punches B, E., Johnson K, D., Acquavita S, P., Felblinger D, M., & Gillespie G, L. (2019). Patient perspectives of pregnancy loss in the emergency department. *International emergency nursing, 43*, 61-66. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2018.10.002

Quenby, S., Gallos, I., K Dhillon-Smith, R., Podesek., M, Stephenson D., J, Fisher., Brosens J, Brewin, J., Ramhorst, R., Lucas S, E., McCoy C, R., Anderson, R., Daher, S., Regan, L., Al-Memar, M., Bourne, T., MacIntyre A, D., Rai, R., Christiansen B, O., Sugiura-Ogasawara, M., Odendaal, J., Devall J, A., Bennett R, P., Petrou, S., & Coomarasamy, A. (2021). Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychologial, and economic costs of pregnancy loss. *The Lancet; London, 397(10285)*, 1658-1667. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00682-6

Redinger, A., & Nguyen, H. (2024). Incomplete Miscarriage. *StatPearls*. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559071/

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). *Etikboken: Etik för vårdande yrken* (2 uppl.). Studentlitteratur

Schout, G., de Jong, G., & Zeelen, J. (2010). Establishing contact and gaining trust: an exploratory study of care avoidance. *Journal of Advanced Nursing, 66(2)*, 324-333. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05171.x

Svensk förening för obstetrik & gynekologi. (2021). *SFOG-råd för behandling av missfall från FARG.* Microsoft Word - SFOG råd Behandling-av-missfall .docx

Svensk sjuksköterskeförening. (2021). *ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.* https://swenurse.se/download/18.7104a0bd1817fce0092f0132/1656659417909/A4%20ICN%20Etiska%20kod%20enkelsidor.pdf

Svensk sjuksköterskeförening. (2024). *Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.* Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska 2024.pdf

Swanson M, K. (1999). Effects of Caring, Measurement, and Time on Miscarriage Impact and Women's Well-Being. *Nursing Research, 48(6)*, 288–298. https://doi.org/10.1097/00006199-199911000-00004

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed.* Vetenskapsrådet. God forskningssed 2024 - Vetenskapsrådet

Världshälsoorganisationen. (2025). *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics.* ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics

Östlundh, L. (2022). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), *Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.* (4 uppl., s. 79-109). Studentlitteratur.

*Özcetin, E., & Boz, I. (2022). The meaning of hope in the Experience of Prenatal Loss for the first time: A phenomenological Study with Drawings. *Journal of Education and Research in Nursing, (19)3*, 290-297. DOI:10.5152/jern.2022.58826

BILAGA 1. Sökmatris

Databas	**Sökblock** **Sökord**	**Antal** **träffar**	**Begränsningar**	**Antal lästa** **abstrakt**	**Antal lästa** **artiklar**	**Valda artiklar till** **resultat, se bilaga 2.**
Cinahl Complete 22/1	MH "Abortion, Spontaneous+" AND (Experience*)	175	2019–01 – 2026–01 Kvinnor 19–44 år Engelska Peer Review	22	8	Bellhouse, C. 2019 Boakye, P. 2025 Furtado-Eraso, S. 2024 Özcetin, E. 2022
Pubmed 22/1	(experience*) AND ("Abortion, Spontaneous"[Mesh])	411	2019–01–2026–01 Kvinnor 19–44 år Engelska	26	6	Crous, M. 2024 Figueredo-Borde, N. 2024 Lariviére-Bastien, D. 2019 Levitan, F. 2025 Lockett, M. 2024 Punches, B. 2019

BILAGA 2. Matris över urval av artiklar till resultat

Författare	**Titel**	**År, land, tidskrift**	**Syfte**	**Metod** (Urval, Datainsamling, Analys)	**Resultat**
Bellhouse, C., Temple-Smith, M., Watson, S. & Bilardi, J.	"The loss was traumatic... some healthcare providers added to that": Women's experiences of miscarriage.	2019, Australien, Women and Birth	Syftet var att undersöka den psykiska påfrestningen hos kvinnor som gått igenom ett missfall	**Metod:** Kvalitativ **Urval:** 15 kvinnor mellan 18–50, förstå engelska bra samt genomgått ett missfall för minst 3 månader sen men inte mer än 10 år sedan. **Datainsamling**: Semistrukturerade interjuver **Analys:** Tematisk analysmetod	Olika teman identifierades i resultaet. Kvinnorna upplevde känslor som sorg, förlust, isolering och påfrestning efter missfall. De visade även kliniska tecken på depression och ångest. Kvinnorna upplevde även brist på information och uppföljning. Deltagarna ger även sin syn på hur vårdpersonalen kan förbättra sitt bemötande och vårdande.
Boakye N. P., Prendergast N., Obewu Thomas	"I Was Shattered and Broken": Unmasking the Experiences and	2025, Kanada, Canadian Journal of Nursing Research	Syftet var att undersöka svarta kanadensiska kvinnors upplevelser och	**Metod:** Kvalitativ **Urval:** 32 kvinnor över 18 år som identifierade sig	Kvinnorna upplevde känslor som tvivel, skuldbeläggning och tomhet. Även chock och overklighet upplevdes också. De hade svårt att

Abanta O., & Mugambi, D.	Responses of Black Canadian to Pregnancy Loss.		reaktioner vid en förlorad graviditet	som svarta samt upplevt minst en graviditetsförlust **Datainsamling:** Interjuver med både ostrukturerade och semistrukturerade frågor. **Analys:** Tematisk analysmetod	hantera känslorna och acceptera vad som hänt och förnekelse av situationen var vanlig. Kvinnor upplevde att dem blev isolerade och kände sig misslyckade. Flera kvinnor upplevde även brist på emotionellt stöd.
Crous, M., Motsohi, T. & Adeloye, A. A.	Witzenberg Women's experience of health care after a miscarriage: A decriptive qualitative study	2024, Sydafrika, African Journal of Primary Health Care & Family Medicine	Syftet var att undersöka och beskriva kvinnors erfarenheter av vården efter ett inkomplett spontant missfall inom Western cape, Sydafrika.	**Metod:** Beskrivande och explorativ kvalitativ **Urval:** 8 kvinnor över 18 år som drabbats missfall och fått vård på Ceres District Hospital mellan augusti 2021 och maj 2022 **Datainsamling:** Semistrukturerade intervjuer. **Analys:** Ramverksmetod.	Resultaten visar på att kvinnor upplever brist på respektfull, säker och stödjande vård. De uttryckte rädsla, inget skydd av integritet, känslomässig och fysisk smärta. De beskrev att majoriteten av personalen saknade empati och dömde deras situation. Kvinnor upplevde även övergivenhet och att ingen bryr sig. De negativa upplevelserna vägde tyngre än dom positiva.
Figueredo-Borda, N., Ramirez-	Experiences of miscarriage: the voice of parents	2024, Australien, Omega: Journal of Death & Dying	Syftet var att utforska kvinnors upplevelser av missfall.	**Metod:** Kvalitativ **Urval:** 15 kvinnor som upplevt missfall efter högst	Resultaten visar att kvinnor som förlorat ett barn i tidig graviditet upplever djup sorg, isolering och

Pereira, M., Gaudiano, P., Cracco, C. & Ramos, B.	and health professionals.			20 veckor eller att fostrets vikt över 500 g. **Datainsamling:** Enskilda **i**ntervjuer. **Analys:** Innehållsanalys	behov av att erkänna barnet för att bearbeta förlusten. En smärtsam och livsomvälvande situation med känslor av sorg och ensamhet. De upplevde även psykisk ohälsa som nedstämdhet, långvarig sorg och tomhet. Andlighet, stöd från familj och vårdpersonal samt respektfull vård spelar en avgörande roll för att hantera sorgen och minimera psykisk skada.
Furtado-Eraso, S., Marin-Fernandez, B. & Escalada-Hernandez, P.	"Perinatal loss, a devastating cyclone": A situation-specific nursing theory.	2024, Spanien, Journal of Nursing Scholarship	Syftet var att utveckla en preliminär teori som på djupet utforskar och förstå kvinnors upplevelser av spontan perinatal förlust under vilken trimester som helst av graviditeten, med fokus på deras känslomässiga reaktion på denna förlust.	**Metod:** Kvalitativ **Urval:** 25 kvinnor som varit med om spontan perinatal förlust. **Datainsamling:** Enskilda intervjuer. **Analys:** Grundad teori	Kvinnorna upplevde att deras drömmar, förhoppningar och förväntningar krossades. Vid missfallet upplevdes känslor som ångest, chock och hopplöshet. Kvinnorna upplevde både fysiska och psykiska reaktioner. Andra känslor som upplevdes var sorg, rädsla, skuld och ilska. Kvinnorna hade även en önskan om mer information under

					förloppet för att få mer trygghet när det kändes okontrollerbart.
Lariviére-Bastien, D., deMontigny, F. & Verdon, C.	Women's Experiences of Miscarriage in the Emergency Department	2019, Kanada, Journal of Emergency Nursing.	Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av missfall på akutmottagning samt att identifiera specifika kännetecken hos vårdpersonalen som bidrar till deras utmaningar	**Metod:** Fenomenologisk **Urval:** 48 kvinnor 18 år och äldre som upplevt minst ett misfall inom de senaste 4 åren och sökt vård på akutmottagning och fått diagnosen missfall. **Datainsamling:** Semistrukturerade interjuver **Analys:** Tematisk dataanalys utifrån Paille.	Kvinnorna upplevde att det kände sig oförberedd inför de känslomässiga och fysiska konsekvenserna efter ett missfall som ledde till negativa långsiktiga effekter på det psykiska måendet. De beskrev känslor som frustration, stress, panik och traumatiska situationer. Kvinnorna upplevde även att deras svårigheter hade lindrats om vårdpersonalen hade gett bättre stöd och information.
Levitan, F., Frei-Landau, R. & Sabar-Ben-Yehoshua, N.	"I just needed a hus": Culturally-Based Disenfranchised Greif of Jewish Ultraorthodox Women	2025, Israel, Journal of Death and Dying.	Syftet var att undersöka upplevelser av missfall inom den unika gruppen.	**Metod:** Kvalitativ **Urval:** 14 judiska ultraortodoxa kvinnor mellan 21–65 som hade upplevt ett missfall mellan vecka 8–20.	Kvinnor upplevde utmaningar med att inte få fysiskt stöd på grund av kulturen och kamp att balansera mellan egna känslor och sin makes. Dom upplevde även svårigheter att berätta för vänner och familj på grund av känslor av tabu, misslyckande men också att få utrymme att sörja själv.

	Following Pregnancy Loss			**Datainsamling:** Interjuver med hjälp av ett tvåstegsinterjuvprotokoll **Analys:** Sexstegsprocess för induktiv tematisk analys.	Kvinnorna upplevde känslor som ensamhet, brist på tröst, misslyckade och skam. Kvinnorna kände sig även ifrågasatta och upplevde sig som avvikande eller defekta.
Lockett, M. & Mash, J. R.	Lived expereinces of women with spontaneous abortion at a district hospital, South Africa	2024, South Africa, South African family practice	Syftet var att undersöka de levda erfarenheterna hos kvinnor som söker till akutmottagningen på Helderberg-sjukhuset med spontana aborter.	**Metod:** Kvalitativ **Urval:** 9 kvinnor över 18 år, som gått igenom missfall. **Datainsamling:** Semistrukturerade individuella intervjuer. **Analys:** Ramverksmetoden och programvaran Atlas.ti (version 22)	Kvinnorna upplevde ensamhet, brist på empati och medkänsla från personalen. Efter missfallet kände som sig tomma och chockade och utdömda. Detta kunde leda till att dom kände sig uteslutna att vara delaktiga i deras vård. Flera kvinnor upplevde känslor som ångest, förvirring och oförståelse till varför missfallet skedde och hade önskat att vårdpersonalen berättade mer om förloppet.
Punches, E. B., Johnson, D. K., Acquavita, P. S., Felblinger, M.	Patient perspectives of pregnancy loss in	2019, USA, International emergency nursing.	Syftet var att beskriva kvinnors perspektiv att uppleva graviditetsförlust på akutmottagning.	**Metod:** Kvalitativ **Urval:** 8 kvinnor mellan 21–34 som upplevt missfall på akutmottagningen.	Studien visar att kvinnor som söker akutmottagning vid hot mot graviditeten ofta upplever bristande information och att vårdpersonal. Inte

D. & Gillespie, L. G.	the emergency department			**Datainsamling:** Semistrukturerande interjuver. **Analys:** Öppen kodningsteknik	fullt ut förstår deras situation. Hur sorgeprocessen bemöts i akutsjukvården kan antingen stödja eller försvåra återhämtningen, vilket visar behovet av förbättrad vård och kommunikation. Kvinnorna bristande integritet, rädsla när ingen information tillkänna gavs och en plågsam väntan till diagnos. Kvinnorna upplevde ett emotionellt berg och dalbana av olika typer av känslor under väntan till diagnos.
Özcetin, E. & Boz, I.	The Meaning of Hope in the Experience of Prenatal Loss for the First Time: A phenomenological Study with Drawings	2022, Turkiet, Journal of Education and Research in Nursing	Syftet var att undersöka känslor, tankar och upplevelser hos kvinnor som genomgår en graviditetsförlust och hur dem uppfattar hopp.	**Metod:** Beskrivande fenomenologisk **Urval:** 17 kvinnor som upplevt missfall vid Akdeniz University hospital. **Datainsamling:** Semistruktrerade interjuver	Kvinnorna upplevde känslor som förlust av framtiden, hopp, besvikelse, att bli mamma och drömmar om barnet. Känslorna kopplas till en storm på insidan där känslor går upp och ner. De upplevde en plågsam smärta att lämna sjukhuset utan sitt barn. Kvinnorna hoppade även mellan att vara hoppfulla, känna både

				Analys: Braun och Clarks sexstegs tematiska analysmetod	hopp och hopplöshet samt en fullständig hopplöshet.

Bilaga 3, kvalitetsgranskning

Artikel	**Kvalitet** **Låg/medel/hög**
"The loss was traumatic... some healthcare providers added to that": Women's experiences of miscarriage.	Hög
"I Was Shattered and Broken": Unmasking the Experiences and Responses of Black Canadian to Pregnancy Loss.	Hög
Witzenberg Women's experience of health care after a miscarriage: A decriptive qualitative study	Hög
Experiences of miscarriage: the voice of parents and health professionals.	Medel
"Perinatal loss, a devastating cyclone": A situation-specific nursing theory.	Hög
Women's Experiences of Miscarriage in the Emergency Department	Hög
"I just needed a hus": Culturally-Based Disenfranchised Greif of Jewish Ultraorthodox Women Following Pregnancy Loss	Hög
Lived expereinces of women with spontaneous abortion at a district hospital, South Africa	Hög
Patient perspectives of pregnancy loss in the emergency department	Medel
The Meaning of Hope in the Experience of Prenatal Loss for the First Time: A phenomenological Study with Drawings	Hög